（七）格列奈类（小高峰持续时间短，低血糖不良反应没有磺脲类严重）

①代表：瑞格列奈、那格列奈
②很适合 **T2DM 瘦瘦降餐后高血糖** 促进胰岛素早时相分泌

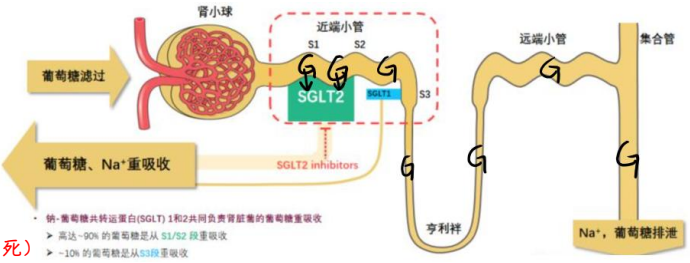
（八）噻唑烷二酮类

①代表：罗格列酮、吡咯列酮
②激活过氧化物酶体增殖物激活受体 PPARγ→增加靶组织对胰岛素敏感性
③很适合 T2DM 胖胖、胰岛素抵抗明显者
④心衰禁用（心塞）因为该药会导致水肿

（九）SGLT-2i 降糖降压，护心护肾

①**代表：达格列净、恩格列净**
②抑制近端小管管腔侧 Na-G 共转运蛋白 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓。**SGLT-2i 护肾护心，能降低血糖、肾糖阈、血压、尿蛋白排泄、血脂、体重、尿酸、心血管死亡率**（受够了糖不要重吸收了、给我清干净）
③适合 T2DM 都给我清干净（渗透性利尿）

抑制Na-G同向转运体-2（SGLT-2）
↓　↓
渗透性利尿←重吸收G↓　重吸收Na+↓→血压↓
↓　↓
血糖↓　致密斑Na+↑→肾素↓→AngII（选择性收缩出球A）↓
↓
GFR↓ 滤过蛋白质↓尿蛋白排泄↓
（保护肾脏，
因为高压力高蛋白高滤过会把有功能的处于代偿的肾单位累死）



（十）二肽基肽酶 DPP-4 抑制剂

①代表：沙格列汀、西格列汀（打屁屁就听话）
②抑制 DPP-4→提高 GLP-1
③适合 T2DM

专题串联 • 糖尿病治疗药物小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）药物小结

1.**促胰岛素分泌**
①**磺酰脲类**（格列 XX）、**格列奈类**
②**基于肠促胰素**（如胰高血糖素样肽 GLP-1）：**GLP-1 受体激动剂（肽）、DPP-4 抑制剂（格列汀）**

2.最易出现**低血糖**不良反应
①**胰岛素＞磺酰脲类＞格列奈类**（胰岛素被尿出来、奶挤出来）
②低血糖的表现：心慌、出汗（**皮肤湿润**）、饥饿感、昏迷（交感N兴奋　脑非常依赖G）
昏迷鉴别：HHS、DKA、脑水肿、乳酸酸中毒、低血糖
（强大的渗透性利尿 有不恰当的 双胍用药史　皮肤湿润、心慌
皮肤干燥　治疗方法）

3.可致**体重增加：胰岛素、磺酰脲类、格列奈类、噻唑烷二酮类**（格列酮）、**西格列他钠**
（胰岛素长胖子　干重　激动PPAR 导致水肿（湿重））

VS 新型促胰岛素分泌剂：①减肥②生理情况下GLP-1不会出现低血糖